

OPHTALMOLOGIE

Dr.KHERBA_N

OPHTALMOLOGIE

Blépharite

Brûlure oculaire

Chalazion

Conjonctivites

Dacryocystite

Episclérite

Herpès ophtalmique

Myiase oculaire

Orgelet

Ptérygion

Sécheresse oculaire

Trachome

Zona ophtalmique

Blépharite

● Clinique :

Inflammation du revêtement cutané des paupières

Souvent d'origine microbienne ou allergique

Œdème isolé, prurit, sensation de Brûlure à l'intérieur de l'œil +/- sécrétions purulentes.

✓ Traitement : 10j

1 Tobrex / Chibrocardon / Maxidrol collyre
1gtt 3/j

2 Sterdex / Maxidrol pmd 1app le soir

Compresse chaude 3/j pdt 15 min



Brûlure oculaire

✓ CAT :

- Lavage abondant au SSI prolongée 15_30min
- Protéger l'œil de la lumière et des frottements

1 Indocollyre coll 1gtt 3/j

2 Dacryosérum coll 1gtt 1/j

→ Avis ophtalmologie en urgence

- Brûlure chimique :
- Lavage prolongée à l'eau
- Coll ATB
- Coll cicatrisant (Vit A)
- Atropine 1% en coll
- Pansement oculaire

- Brûlure thermique :

- Coll ATB

- Coll cicatrisant

- AINS

Chalazion

● Clinique :

Occlusion inflammatoire non infectieuse de glande, se localise à l'épaisseur de la paupière

Chronique, dur, indolore, pas de rougeur

✓ Traitement :

1 Frakidex/Chibrocardon/Maxidrol coll 1gtt
3/j 10j

2 Frakidex/Sterdex/Maxidrol pmd 1app le
soir pdt 7j

■ Massage par une compresse avec de l'eau
tiède pdt 10min 2_4/j

■ Enfant 🧒 :

1 Maxidrol collyre 1gtt 2/j

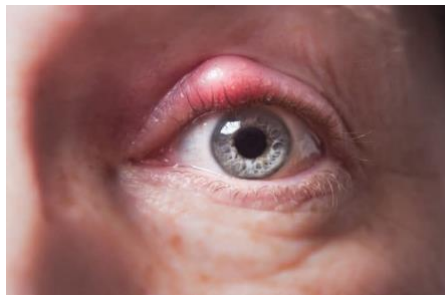
2 Sterdex/Maxidrol pmd 1/j

3 Lavage au SSI

■ Si Résistance après 15j=> Renouveler le traitement

■ Si pas de réponse: Infiltration des CTC

■ Si non → chirurgie



Conjonctivites

● Conjonctivite bactérienne :

- 1 Chibroxine/Tobrex/Desomedine collyre
1gtt 3/j pdt 7_10j
- 2 Fucithalmic/Neomycine pmd 1app le
soir
- 3 Lavage oculaire au Dacryosérum

■ Enfant : 🍼

Lavage abondant au SSI avec une seringue
des 2 yeux

- 1 Chibroxine/Desomedine/Rifamycine coll
1gtt 4/j pdt 7j
- 2 Fucithalamic/Rifamycine pmd 1app le
soir

■ Nourrisson : 

■ Rifamycine collyre + pmd

Ou Desomedine/Tobrex/Azyter coll 2/j pdt 3j
1 matin et 1 soir

+ Fucithalmic pmd le soir

■ Femme enceinte 

1 Lavage oculaire au SSI

2 Azyter coll 1gtt 2/j pdt 3j

Ou Erythromycine coll/pmd 1app 2_3/j pdt
7j

⚠ Pas de CTC ni Tétracyclines ni
Fluoroquinolones

● Conjonctivite Virale :

1 Chibroxine/Desomedine coll 1gtt 3/j

2 Fucithalmic/Rifamycine pmd 1app le
soir

3 Dacryosérum 1lavage 4/j

■ Enfant 🧒 :

■ Vitbact coll 1gtt 4/j

● Les conjonctivites infectieuses:

- Virale se surinfecte vite (secondaire au grattage des yeux)
- En l'absence des signes de gravité ou de FDR:

Chémosis, œdème palpébral, sécrétions importantes, photophobie, BAV, ID, pathologie oculaire..

- Lavage oculaire au sérum
- Antiseptique
(Dacryosérum/Vitbact/Biocidan) coll 4/j pdt 7j

Mais le Dacryosérum: pression directement sur le flacon, pas de goutte

- Si non: ATB 4/j pdt 10j
- Si BAV, douleur + photophobie
- Avis ophtalmologie

● Conjonctivite allergique :

■ Bilatérale d'emblée, chémosis, prurit intense, sécrétions claires..

1 Nabak/Naaxia/Levophta/Zalerg coll 1gtt 3/j pdt 7j

+ Fluidback (lubrifiant)

■ Si terrain allergique :

2 Clarityne cp 1cp/j pdt 1mois

Ou Primalan sirop 1cac/j le soir pdt 7j

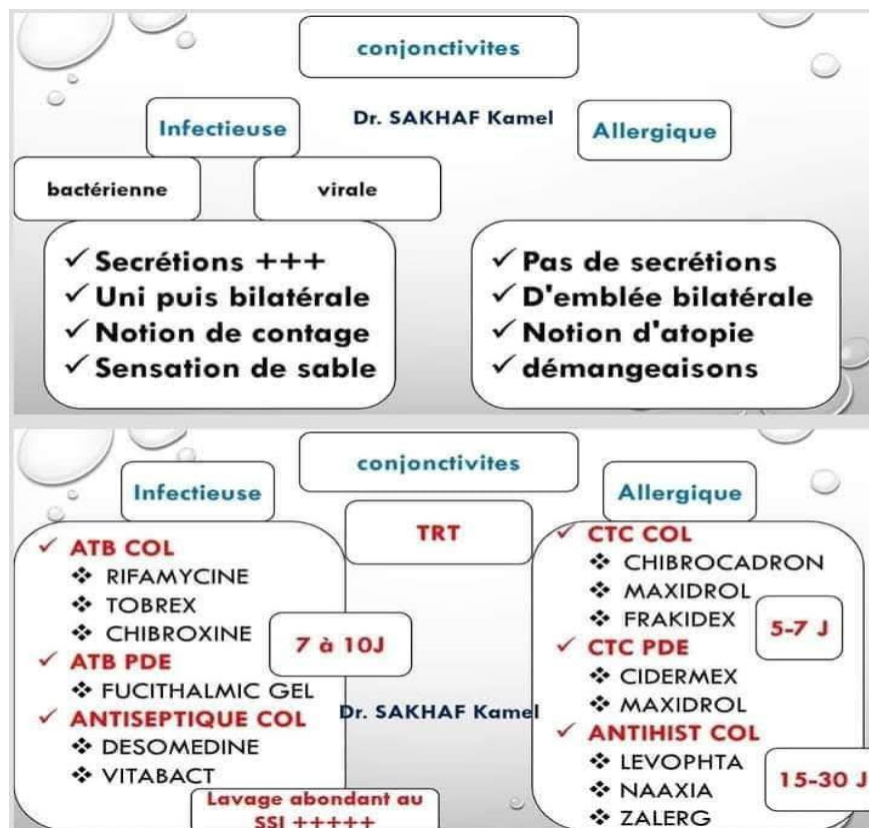
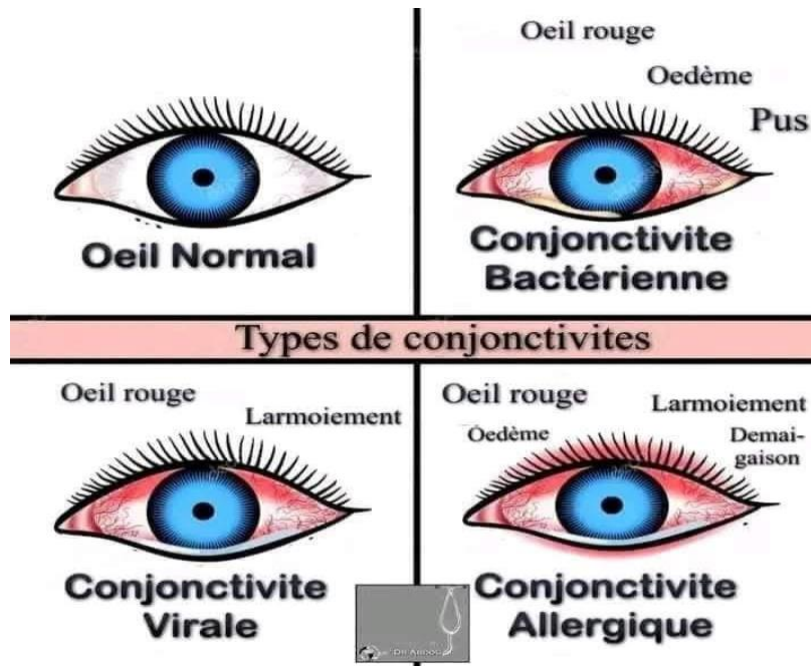
3 Dacryosérum 1gtt 3/j

■ Enfant 🧒 :

1 Naaxia coll 1gtt 3/j Ou Levophta >6ans

2 Histagan sirop 1cac 2/j

3 Dacryosérum 1gtt 3/j



Dacryocystite

● Clinique :

Inflammation du sac lacrymal

Larmoient clair puis purulent

Unilatérale puis bilatérale

✓ Traitement :

1 Rifamycine collyre 1gtt 4/j pdt 10j

A distance des autres de 15min

2 Vitbact collyre 2gtt 6/j pdt 10j

3 ATB per os

■ Si pas de réponse → Chirurgie



Episclérite

● Clinique :

Maladie inflammatoire bénigne et spontanément résolutive affectant une partie de l'œil

Fine couche de tissu située entre la conjonctive et la couche de tissu conjonctif qui forme le blanc de l'œil..

- 1^{er} épisode => Bénin
- Récidives=> Rechercher une maladie de système : Bilan immunologique
- Instillation de Phényléphrine :
- Disparition de rougeur : Episclérite
- Persistance de rougeur : Sclérite

✓ Traitement :

- 1 Indocollyre coll 1gtt 4/j
- 2 Maxidrol collyre 1gtt 3/j
- 3 Maxidrol pmd 1app/j le soir



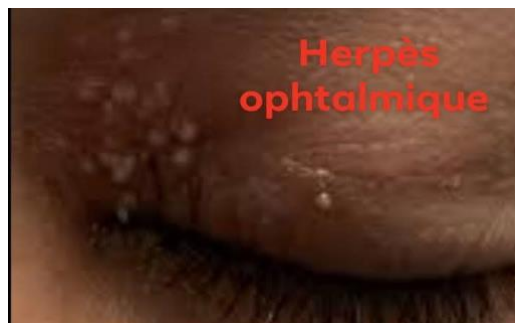
Herpès ophtalmique

● Signes infectieux : Rougeur, douleur..

✓ Traitement :

Aciclosina pmd 1app 3/j pdt 10j

Ou Clovirax



Myiase oculaire

● Présence de larves de mouches..

- Lavage oculaire fréquent au SSI
- Xlylocaïn Ou Cebesine pmd
- Appliquer la pmd puis enlever les lèbres au coton tige

✓ Traitement :

1 Tobrex/Chibroxine/Desomedine coll
1 app 5/j

2 Clomycine pmd 1 app 2/j

3 Siccafluid

4 Pansement oculaire

■ Si non réponse → Avis ophtalmologie



Orgelet

● Clinique :

Infection d'un follicule du cil d'origine strepto, se localise au rebord palpébral

Petite boule centrée sur un poils contenant du pus

Rouge et douloureux

✓ Traitement : pdt 15j

1 Rifamycine/Tobrex/Azyter/Chibroxine
collyre 1gtt 3/j

2 Rifamycine/Tobrex/Fucithalmic pmd
1app le soir pdt 10j

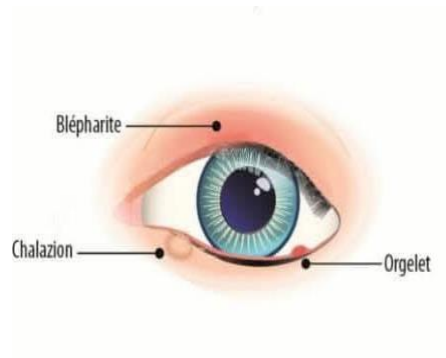
- Si échec du traitement => à refaire pdt 15j
- Piquer avec aiguille

■ Enfant 🧒

1 Rifamycine /Tobrex/ Azyter/ Chibroxine
collyre

2 Rifamycine/Tobrex/ Fucithalmic pmd

■ Si non → Chirurgie



Ptérygion

● Clinique :

Invasion cornéenne issue de la conjonctive limbique

Lésion bénigne de la conjonctive, membrane superficielle qui tapisse la surface de l'œil

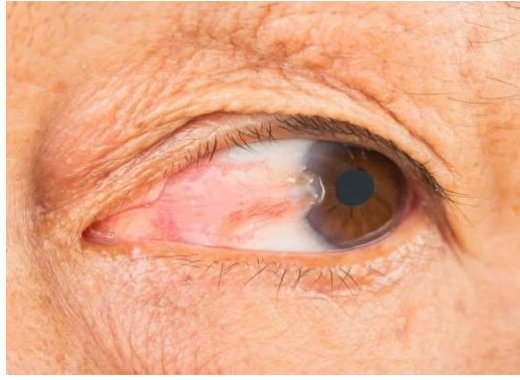
Atteinte de la vision ☐ chirurgie

✓ Traitement :

☐ 1 Maxidrol coll 1gtt 3/j pdt 10j

☐ 2 Maxidrol pmd 1app 2/j pdt 10j

■ Après 10j : Diclofenac coll 1gtt 3/j



Sécheresse oculaire

- Aqualarm
- Artelac
- Cicafluid
- Fluidback
- Freshall
- Hyfresh
- Liposic gel
- Siccafluid
- Therafresh
- Thealose

Trachome

● Clinique :

Infection oculaire bactérienne non spécifique et contagieuse causée par *Chlamydia trachomatis*.

Larmolement, photophobie, sensation du Brûlure et de corps étranger, hypersécrétion.

✓ Traitement :

Tétracycline pmd 1% 1 app/j pdt 6sem

Ou Azithromycine cp 20mg/kg dose unique

■ Azyter coll 1gtt 2/j pdt 3j



Zona ophtalmique

✓ CAT :

- Éviction scolaire jusqu'à disparition des croûtes
- Vaccination

- Traitement symptomatique :
- Bains quotidiens et soins locaux
- Antalgique : Codolyc

- Traitement antiviral :
- Aciclovir cp 800mg 1cp 5/j pdt 7j
Ou Famciclovir cp 500mg 3/j pdt 7j
Ou Valciclovir cp 1g 1cp 3/j pdt 7j chez
l'immunocompétent

■ Si ID : Aciclovir en IV 10mg/kg tt 8h pdt
7_10j

Virgan collyre 3_4/j

■ Contrôle ophtalmologie à j30

